

CAPÍTULO 13.4

Otras infecciones respiratorias virales

PERFIL EUNACOM 1.04.1.016

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Aunque la **Influenza** es el cuadro viral respiratorio más preguntado, existen otros virus con presentaciones clínicas características que permiten orientar el diagnóstico etiológico en la práctica clínica y en el examen EUNACOM.

Adenovirus: La gran simuladora bacteriana

El **Adenovirus** es conocido por producir cuadros que, por su severidad y hallazgos físicos, suelen confundirse con infecciones bacterianas. Afecta principalmente a niños, siendo especialmente grave en menores de un año (y crítico en menores de 3 meses).

Características Clínicas Clave

- **Fiebre muy alta y prolongada:** Es característico que presente fiebre sobre 38.5°C - 39°C que dura muchos días (frecuentemente una semana completa) antes de ceder. - **Amigdalitis Exudativa en lactantes:** Es la causa típica de amigdalitis con placas (exudado) en menores de 3 años. - **Fiebre Faringoconjuntival:** Tríada de fiebre, faringitis y conjuntivitis viral. Es un cuadro altamente sugerente de Adenovirus. - **Compromiso Respiratorio Bajo:** En niños pequeños puede evolucionar a una **Neumonía Adquirida en la Comunidad** de etiología viral.

TABLA 13.4.1: CARACTERÍSTICA VS EXUDADO VIRAL (ADENOVIRUS/EBV)

CARACTERÍSTICA	EXUDADO VIRAL (ADENOVIRUS/EBV)	EXUDADO BACTERIANO (S. PYOGENES)
Color	Más blanco/blanquecino.	Más grisáceo o amarillento.
Ubicación	Superficial, sobre la amígdala.	Localizado en los surcos o criptas amigdalinas.
Edad típica	Frecuente en menores de 3 años.	Principalmente entre 5 y 15 años.
Síntomas asociados	Conjuntivitis, rinitis, tos, diarrea.	Petequias en paladar, adenopatía cervical dolorosa, ausencia de tos.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El diagnóstico de la faringoamigdalitis estreptocócica es clínico-epidemiológico (Criterios de Centor). No indiques antibióticos basándote solo en la presencia de "placas" si el paciente tiene síntomas virales claros (tos, coriza, conjuntivitis).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, si te presentan un niño **menor de 3 años** con **amígdalas con exudado y fiebre**, piensa primero en **Adenovirus** o **Mononucleosis Infecciosa**. La etiología bacteriana por *Streptococcus pyogenes* es muy rara en este grupo etario.

Virus Respiratorio Sincicial (VRS) y Metaneumovirus

Ambos virus comparten una presentación clínica casi idéntica. Mientras que en adultos sanos suelen provocar un cuadro de "resfrío común" indistinguible de otros virus, su importancia radica en la patología pediátrica.

- **Bronquiolitis:** El VRS es la causa principal. Se define clásicamente como el **primer episodio de sibilancias** (SBO) en un niño menor de 1 año (algunas guías extienden este criterio hasta los 2 años).
- **Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO):** Puede generar crisis obstructivas recurrentes tras la infección inicial.

NOTA CLÍNICA

La **Bronquiolitis** por VRS produce inflamación y obstrucción de la pequeña vía aérea por detritus celulares y edema, lo que explica la auscultación de sibilancias y crépitos.

Virus Parainfluenza: El virus de la vía aérea superior

El **Virus Parainfluenza** tiene un tropismo especial por la laringe.

- **En adultos:** Suele manifestarse como una laringitis (disfonía/ronquera) o un resfrío común.
- **En niños (especialmente < 5 años):** Es la causa principal de la **Laringitis Obstructiva Aguda (Crup Viral)**.
 - Se caracteriza por edema subglótico que genera **estridor inspiratorio**, tos "perruna" o de "foca" y disfonía.
 - Puede comprometer gravemente la vía aérea.

Diagnóstico Diferencial: Exudado Viral vs. Bacteriano

Es fundamental distinguir el exudado faríngeo para evitar el uso innecesario de antibióticos. Esta distinción aplica para Adenovirus, **Mononucleosis Infecciosa** (EBV) y otros virus.

Resumen de Manejo

- En la gran mayoría de estos cuadros, el tratamiento es **sintomático**:
- Hidratación abundante.
- Manejo de la fiebre (Paracetamol/Ibuprofeno).
- Aseo nasal con suero fisiológico.
- **Excepción:** En la **Laringitis Obstructiva Aguda** (Parainfluenza) con estridor, el manejo específico incluye corticoides (Dexametasona dosis única) y, según severidad, adrenalina racémica nebulizada.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Recuerda que el manejo de la mayoría de las infecciones respiratorias virales en APS es de soporte. La clave es la educación a los padres sobre los **signos de alarma** (retracción costal, cianosis, dificultad para alimentarse).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Lactante de 2 años consulta por odinofagia, fiebre de 39.5°C de 5 días de evolución y al examen físico se observan placas blancas superficiales en ambas amígdalas. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Otras infecciones respiratorias virales. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El adenovirus afecta con mayor gravedad a niños, especialmente menores de 1 año y de 3 meses
- Las infecciones por adenovirus cursan con fiebre alta ($>38.5^{\circ}\text{C}$) que puede durar hasta una semana
- El adenovirus causa amigdalitis exudativa en menores de 3 años y fiebre faringoconjuntival
- El exudado viral es blanco y superficial; el bacteriano es gris-amarillento y en surcos amigdalinos
- El VRS y metaneumovirus son los agentes clásicos de bronquiolitis en lactantes
- La bronquiolitis es el primer episodio de SBO en un menor de 1-2 años
- El virus parainfluenza tiene tropismo por la laringe y causa laringitis obstructiva en menores de 3-5 años
- El manejo de la mayoría de las infecciones virales respiratorias es sintomático

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (OTRAS INFECCIONES RESPIRATORIAS VIRALES)**PREGUNTA 1**

Lactante de 2 años consulta por odinofagia, fiebre de 39.5°C de 5 días de evolución y al examen físico se observan placas blancas superficiales en ambas amígdalas. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- A)** Streptococcus pyogenes
- B)** Adenovirus
- C)** Virus respiratorio sincicial
- D)** Virus parainfluenza
- E)** Virus influenza

PREGUNTA 2

Niño de 2 años previamente sano, consulta por cuadro de 2 días de evolución con rinorrea, tos perruna, estridor inspiratorio y dificultad respiratoria. No presenta fiebre significativa. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- A)** Adenovirus
- B)** Virus respiratorio sincicial
- C)** Virus parainfluenza
- D)** Rinovirus
- E)** Bordetella pertussis

PREGUNTA 3

Lactante de 4 meses consulta por cuadro de 3 días con rinorrea, tos y sibilancias difusas al examen pulmonar. Es su primer episodio de obstrucción bronquial. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el agente etiológico más frecuente?

- A)** Bronquiolitis por adenovirus
- B)** Asma bronquial por alérgenos ambientales
- C)** Bronquiolitis por virus respiratorio sincicial
- D)** Neumonía bacteriana por neumococo
- E)** Laringitis obstructiva por parainfluenza

RESUMEN: OTRAS INFECCIONES RESPIRATORIAS VIRALES

Existen múltiples virus respiratorios además del SARS-CoV-2 que generan cuadros clínicos característicos. El adenovirus afecta con mayor gravedad a los niños, especialmente menores de un año y con mayor riesgo en menores de tres meses. En niños puede causar tanto infección respiratoria alta como neumonía viral. Es característico que las primeras infecciones por adenovirus cursen con fiebre muy alta (sobre 38.5-39°C) que puede durar hasta una semana completa. El adenovirus es la causa típica de amigdalitis exudativa con placas blancas en menores de tres años. El exudado viral tiende a ser más blanco y superficial sobre las amígdalas, mientras que el bacteriano es más gris-amarillento y se localiza en los surcos amigdalinos. Además, el adenovirus es el agente habitual de la fiebre faringoconjuntival, que asocia faringitis con conjuntivitis viral. El virus respiratorio sincicial (VRS) y el metaneumovirus generan cuadros clínicos similares. En adultos producen resfrío común indistinguible de otros virus, mientras que en lactantes menores de un año son los agentes clásicos de la bronquiolitis y los síndromes bronquiales obstructivos. La bronquiolitis se define como el primer episodio de SBO en un menor de un año (o dos años según autores internacionales). El virus parainfluenza tiene tropismo preferencial por la laringe. En adultos produce frecuentemente laringitis, mientras que en menores de cinco años, especialmente menores de tres años, puede causar laringitis obstructiva con estridor y compromiso de la vía aérea, requiriendo manejo específico. El tratamiento de la mayoría de estas infecciones sigue siendo sintomático.